جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : دعاء رمضان سالم عبدالله
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** العجوزه **العنوان :** مممممممممممممم
رقم البطاقة : 27509012105047 **رقم التليفون :** 01287374229 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 01-09-1975 **المهنة :** حاصل علي دبلوم

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: دعاء رمضان سالم عبدالله
National ID: 27509012105047

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]





National ID - Front & Back
[[DOCTYPE::ID_FRONT_BACK]]

Name: دعاء رمضان سالم عبد الله **MR. :** 5829	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient is a 50-year-old individual with a history of invasive ductal carcinoma, estrogen receptor-positive (8/8), progesterone receptor-positive (8/8), HER2-negative (0). Staging was clinical T2 N1. Neoadjuvant chemotherapy was administered with three cycles of FEC followed by three cycles of TXT, after which breast-conserving surgery was performed (BCS). A port was placed, and the patient received tamoxifen for four years. One month ago, therapy was switched to an aromatase inhibitor (AI) with initiation of letrozole (Femara) and supportive treatment for three months; the last breast self-monitoring was performed in April 2026 and was free of abnormalities.

The patient continues on letrozole (Femara) with supportive therapy for a total of three months, and the next clinic appointment is scheduled for 20 September 2026.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : Reham Ahmed Fathy Ibrahim

يعتمد ,

MDT FORM

5/4/2022

Name	[illegible]	MRN	C·C1 1 ٣٧C٨
		ID	C·٧٥·٩·١C١·٥·٤٧
Age	46	Phone	·١C٨٧ ٣٧٤ CC٩
Menopausal status	Pre menopausal	marital status	
OCP		Family history	
Co morbidity	—		

Clinical Data

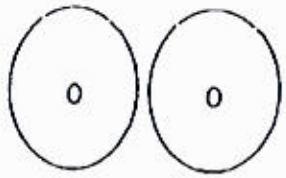
Bx: IDC GII

ER:	PR:	HER 2:	Ki67
8/8	8/8	—	30 %

Sonomammography :

Mets Workup:

R L



cT2N1M0
ypT1N1M0

Recommendations:

NACT : 3 FEC → 3 Taxotere last one 24/11/2022.
- clip insertion befor 2nd cycle.
- WLE + SLNB → IDC GII + 5% DCIS LN 1/14 é Focal extra capsular extension.

24/3/2022

MDT OUTCOME & PLAN

for Tamoxifen 5 years then AI 5 years
(ealandrol) (femara)
PORT

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
[signature]		[signature]	
5/4/2022		5/04/2022	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	: الأستاذه / دعاء رمضان سالم	Request No.	: 13000446
Patient No.	: 27509012105047	Request Date	: 13/03/2022
Path No.	: 713/22	Verification Date	: 20/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 46 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer

Nature of the specimen: Lt WLE + ALND
Gross Examination:
- Procedure: WLE measured 6x5cm with covering skin measured 4x2cm
- Localization: Lt
- Tumor extent
  - o Number: One clipped and wire ghided firm gritty greyish white mass
  - o Size: 1.2x1cm
  - o Skin involvement: Free grossly
- Distance from margins: (1.5cm from superior and inferior margins, 4cm lateral, 2.5cm medial, 2cm superficial and 3cm deep margin)
- Lymph nodes number and size: 17 nodules up to 1cm
- Frozen section: Free margins

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII (2+2+2)
- Angioinvasion: present
- Ductal carcinoma in situ: non-comedo 5%
- Lymph node involvement: Positive (1/14) LNs with focal extracapsular extension
- Resection Margins:
  - o Free
- Histologic response to therapy: Pathological Partial Response
- Additional pathologic findings: Focal mucoid activity. - TNI= 20%

Diagnosis:
Left breast cancer, Lt WLE + ALND:

Verified by :
dr.menna atef

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / دعاء رمضان سالم	Request No.	: 13000446
Patient No.	: 27509012105047	Request Date	: 13/03/2022
Path No.	: 713/22	Verification Date	: 20/03/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 46 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- Invasive duct carcinoma GII with 5% Ductal carcinoma in situ (non-comedo) type
- Positive (1/14) LNs with focal extracapsular extension
  - o Free Resection Margins
  - o Pathological Partial Response
- Stage: ypTx ypN1 ypMx

Prof. Lubna Omar
Dr. Menna Atef

Verified by :
dr.menna atef

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: Doua Ramadan Salem Date: 9/9/2021

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. *Chest:*
   - Left breast mass is seen measuring about 2.7 x 1.7 cm with enlarged left axillary lymph node is noted measuring about 1.3 x 1.2 cm
   - No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
   - No hilar or mediastinal lymph nodes.
   - No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
   - Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
   - Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
   - Normal appearance of the dorsal vertebrae.
2. *Abdomen and pelvis:*
   - The liver is enlarged in size with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
   - Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
   - No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
   - Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
   - Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
   - Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
   - Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
   - Normal appearance of the other pelvic organs.
   - No abdominal or pelvic collections.
   - No lytic or sclerotic lesions.

OPINION:

- ***Known case of breast cancer showing left breast mass with enlarged left axillary lymph nodes.***
- ***No pulmonary or hepatic metastatic deposits.***

Dr. Ahmed Rozeka, MSc

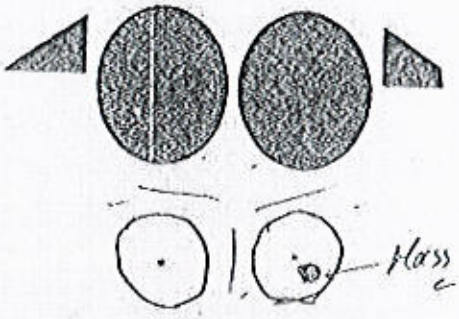
Dr. Amir Karouk, MD

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM

Name	
Age	
MRN	
ID	
Co morbidity	



Clinical Data

Bx: IDC G II	SM: left Multifocal + Pathological axilla LN
IHC: ER: 8/8 PR: 8/8 HerY: 0 KIYY: 30%	Mets Workup: CTCAP → free

T_2 N_0 M_0 (a)

COMMENT:

① CESM then re-MDT (?multi-focal extension & contra-lateral ? nodularity)

3/9/2021 → CESM (Lt. breast ant. malignant mass 4.3×3cm)

MDT OUTCOME & PLAN

In view of relatively large tumor size in relation to breast size → for NACT (FECx3 → Taxol x3) guided by clinical response then consider BCT+ALND vs. for upfront operation.

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]